

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: AFONSO COCENZA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 20-12-2025

Idade: 72 anos

Peso: 67,7 kg

Altura: 1,70 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 20/12/2025 22:08 e finalizado às 21/12/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de 25,1 min e a latência para o sono REM de 84,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 213,5 min, com eficiência do sono de 83,9 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,9 % de estágio N1, 45,9 % de estágio N2, 33,5 % de estágio N3 e 18,7 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 15,9 min. Ocorreram 27 despertares, sendo o índice de 3,6 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 2,8 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 18, sendo 12 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 6 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 5,1 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 1,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 5,9. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 5,1 (nº/h), sendo 3,4 apneia/h e 1,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 95% e a mínima de 89%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 2,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 1,5 (nº/h) e em NREM foi de 5,5 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório leve (5,1 nº/h) (VN= até 5 nº/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (89%);
3. Latência para o início do sono normal (25,1 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (84,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (83,9 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (3,6 nº/h) (VN= até 15 nº/h);
7. Ligeira diminuição do percentual do estágio N1 (1,9 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (45,9 %) (VN= 45% a 55%);
9. Aumento do percentual do estágio N3 ondas delta (33,5 %) (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM (18,7 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, esporádico verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice normal (2,8 (nº/h) (VN= até 15 nº/h);

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico Split-night evidenciando na primeira metade da noite apneia obstrutiva do sono de grau leve.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: AFONSO COCENZA

Data do Exame: 20-12-2025

DADOS DO PACIENTE:

Nome: AFONSO COCENZA
ID: 0
Altura: 1,70 m
Peso: 67,7 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 13-2-1953
IMC: 23,43

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:08:50
Data do Exame: 20-12-2025
Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono

Data/Horário de Início:	20/12/2025 22:08
Data/Horário de Término:	21/12/2025 05:43
Tempo Total de Registro (TTR):	254,5
Tempo Total de Sono (TTS):	213,5
Latência para o início do sono:	25,1
Latência para o sono REM:	84,0
Tempo acordado após o adormecer:	15,9
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	83,9 %

Estágios do Sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	4,0	98,0	71,5	40,0	41,0
% de TTS	1,9	45,9	33,5	18,7	16,1

Despertares			
	Número		Índice (nº/h)
Total despertares	de	27	3,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	53,7	71
NREM	50,8	97
Vigília	57,3	79

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	12	0	12	6	18	0	18
Índice	0,0	3,4	0,0	3,4	1,7	5,1	0,0	5,1
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Índice em NREM	0,0	4,1	0,0	4,1	1,7	5,9	0,0	5,9
Duração máx (seg)	0	36,7	0	36,7	40,3	40,3	0	40,3
Duração média (seg)	0	25,1	0	25,1	31,4	28,2	0	28,2
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 5,1 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 5,1 (nº/h)

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: AFONSO COCENZA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 20-12-2025

Idade: 72 anos

Peso: 67,7 kg

Altura: 1,70 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 20/12/2025 22:08 e finalizado às 21/12/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de 0,1 min e a latência para o sono REM de 54,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 139,5 min, com eficiência do sono de 69,9 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,8 % de estágio N1, 61,3 % de estágio N2, 0 % de estágio N3 e 36,9 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 60,0 min. Ocorreram 3 despertares, sendo o índice de 0,4 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 2, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 2 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 0,9 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 0,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 1,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 0,9 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 0,9 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 96% e a mínima de 92%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 0,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 0,0 (nº/h) e em NREM foi de 2,0 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório normal (0,9 nº/h) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (92%);
3. Latência para o início do sono diminuída (0,1 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM diminuída (54,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (69,9 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (0,4 nº/h) (VN= até 15 nº/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (1,8 %) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (61,3 %) (VN= 45% a 55%);
9. Ausência do estágio N3 ondas delta (0 %) (VN= 13% a 23%);
10. Aumento do percentual do estágio REM (36,9 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, esporádico verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

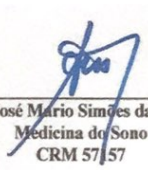
Exame polissonográfico Split-night, na segunda metade da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: AFONSO COCENZA

Data do Exame: 20-12-2025

DADOS DO PACIENTE:

Nome: AFONSO COCENZA
ID: 0
Altura: 1,70 m
Peso: 67,7 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 13-2-1953
IMC: 23,43

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:08:50
Data do Exame: 20-12-2025
Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono

Data/Horário de Início:	20/12/2025 22:08
Data/Horário de Término:	21/12/2025 05:43
Tempo Total de Registro (TTR):	199,5
Tempo Total de Sono (TTS):	139,5
Latência para o início do sono:	0,1
Latência para o sono REM:	54,5
Tempo acordado após o adormecer:	60,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	69,9 %

Estágios do Sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	2,5	85,5	0	51,5	60,0
% de TTS	1,8	61,3	0	36,9	30,1

Despertares			
	Número		Índice (nº/h)
Total despertares	de	3	0,4

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	46,6	56
NREM	46,0	66
Vigília	49,0	70

Apneias/Hipopneias/RERAS								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	2	2	0	2
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4
Duração máx (seg)	0	0	0	0	28,0	28,0	0	28,0
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	27,0	27,0	0	27,0
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 0,9 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 0,9 (nº/h)